

09 - 02-ALGIES PELVIENNES CHEZ LA FEMME - Pr. ABOU LFALAH

Bonjour, ce cours est consacré à l'analyse sémiologique des algies pelviennes chez la femme. Les algies pelviennes désignent les douleurs de la partie basse inférieure de l'abdomen. Il faut les distinguer entre les algies pelviennes aiguës et les algies pelviennes chroniques, parce que les idéologies sont totalement différentes.

Les algies pelviennes aiguës, on les distingue par leur durée d'évolution moins d'un mois, ou le mode de consultation, parce que les algies pelviennes aiguës sont diagnostiquées en urgence ou par les urgences. Concernant les algies pelviennes chroniques, leur évolution se fait sur plus d'un mois, ou lorsqu'elles sont diagnostiquées en consultation sur rendez-vous. Il s'agit d'un motif de consultation très fréquent, aussi bien en médecine générale qu'en gynécologie.

Il s'agit aussi d'un symptôme, si on puisse dire, qui passe partout, parce qu'elle est impliquée dans de nombreuses pathologies, aussi bien organiques que fonctionnelles et psychosomatiques. Les algies pelviennes aiguës peuvent révéler une urgence gynécologique ou extra-gynécologique, et puis les algies pelviennes chroniques peuvent être cycliques, c'est-à-dire en rapport avec les règles, ou non cycliques, sans rapport avec les règles, et qui peuvent être d'origine hyrogénitale ou extra-gynitale. C'est pourquoi l'enquête clinique est toujours primordiale, afin d'orienter et surtout de hiérarchiser les examens complémentaires.

Alors la démarche diagnostique qu'on adopte, c'est toujours, il faut faire un interrogatoire orienté, précis, un examen physique général, surtout un examen gynécologique bien détaillé, et les données de l'interrogatoire, de l'examen physique, doivent déboucher, doivent se orienter vers des examens complémentaires pour asseoir le diagnostic. Alors l'interrogatoire est le capital, il va préciser bien évidemment l'identité de la patiente, son âge, un élément d'orientation très important, sa parité, sa gécité, mais surtout il doit préciser deux principaux éléments d'orientation qui sont très importants pour asseoir le diagnostic. Tout d'abord, il doit préciser l'intensité et la durée d'évolution des algies pelviennes pour les distinguer entre algies pelviennes aiguës, qui peuvent révéler des urgences, et des algies pelviennes chroniques.

Et quand il s'agit des algies pelviennes chroniques, il faut voir leur périodicité par rapport aux règles. Donc c'est quelque chose de capital pour distinguer entre les algies pelviennes chroniques cycliques, en rapport avec les règles, et des algies pelviennes chroniques non cycliques. L'interrogatoire doit préciser un certain nombre de caractéristiques de la douleur, surtout l'aspect évolutif de la douleur, est-ce qu'il y a ou pas une position ontalgique, et voir s'il y a une efficacité quand la patiente prend certaines classes d'ontalgique.

L'interrogatoire précise le siège de la douleur, le siège hypogastrique, il faut s'il y a de droite, il faut s'il y a de gauche, il doit préciser ou il doit rechercher s'il y a des irradiations, caractériser la douleur, le type de douleur, est-ce que le type de tiraillement, d'échéreur, qui peut nous orienter vers une torsion d'annexe, ou ce forme de coup de poing, ou juste une pesanteur, surtout dans

les douleurs pélviques chroniques. L'anamnèse doit rechercher s'il y a des facteurs déclenchants, type d'effort, type rapport sexuel, ou est-ce que ces douleurs, surtout lorsqu'elles sont chroniques, sont apparues après un accouchement, par exemple par déchirure ligamentaire, ce qui nous oriente vers le syndrome de Masters Allen. Est-ce que ces algues sont apparues suite à un cortège, et là on doit être orienté vers des sénéchis, ou une infection post-abortum, les endométrites, ou après une intervention chirurgicale, et là, si les douleurs sont chroniques, on doit évoquer les adhérences post-chirurgicales.

L'anamnèse doit préciser aussi s'il y a des signes d'accompagnement, surtout au niveau de l'appareil urinaire, type dysurie, des pelures mictionnelles. Elle doit préciser les signes digestifs présents selon le nausée, le mumbissement, la diarrhée, la constipation, ou d'alternance constipation-diarrhée. Elle doit rechercher aussi la présence de signes sexuels, type dysménorée, il peut s'agir d'une dysménorée superficielle ou profonde, c'est des douleurs au moment des rapports sexuels.

Elle va rechercher s'il y a un trouble du cycle menstruel, type retard des règles, ou la présence carrément d'une aménorrhée, ou s'il y a un signement génital associé. Il faut toujours préciser si ces douleurs surviennent dans un contexte de conflit social, familial ou professionnel. L'interrogatoire va préciser les antécédents, les antécédents familiaux de pathologies digestives, de cancers familiaux.

Il doit préciser aussi l'histoire gynécologique, mais c'est surtout les antécédents personnels, médicaux, une pathologie hépatique, urinaire, digestive, la prise au nom d'un certain nombre de médicaments et la notion d'une éventuelle toxicomanie. Il faut préciser au niveau des antécédents chirurgicaux la présence ou non d'une appendicectomie, et puis préciser les antécédents gynécologiques, s'il y a eu une infection sexuellement transmissible, s'il y a eu une sépingite, une herpès génital, et il faut préciser si la patiente a des difficultés à concevoir type infertilité. Dans les antécédents, il faut rechercher si la patiente ayant déjà fait une fausse couche spontanée, une grossesse extra-utérine ou s'il y a eu des complications gravidiques et obstétriques.

Après cet interrogatoire, l'examen général doit préciser l'état hémodynamique, c'est quelque chose de très important, surtout quand il s'agit d'algues aiguës, parce qu'elles peuvent révéler une urgence, par la prise de la tension artérielle, le pouls, la fréquence respiratoire. Il faut rechercher s'il y a un syndrome fibril par la prise systématique de la température, voir rapidement le contexte psychique dans lequel ces algues aiguës sont apparues, et faire un examen de l'abdomen. L'examen de l'abdomen doit préciser s'il y a une douleur élective, s'il y a une défense localisée, s'il y a une contracture généralisée au niveau de l'abdomen qui évoque une urgence grave.

Il faut examiner l'hépatocyste droit, à la recherche d'un syndrome de Murphy, par l'ébranlement du foie, de la vésicule, à la recherche d'une péritonite qui peut se voir dans les infections

sexuellement transmissibles, en particulier par les chlamydiens. Il faut palper le cadre colique à la recherche d'une colite spasmodique, et au niveau de la fosse iliaque droite, il faut chercher éventuellement une appendicite, en particulier par la douleur au niveau du point de Murphy. Cet examen général doit aussi palper les fosses lombaires, à la recherche d'une douleur à la pression ou à l'ébranlement des fosses lombaires, il faut aussi rechercher un contact lombaire.

Après cet examen général, il faut passer à l'examen gynécologique proprement dit. Il faut commencer tout d'abord par une inspection de la région vulvopérinéale, à la recherche de signes d'infection, d'une tumeur, ou d'un écoulement vaginal, et il faut le caractériser. Après cette inspection, il faut faire un examen sous spiculum pour voir l'état du corps utérin, l'aspect de la glaire cervicale, il faut voir tout le vagin, et cet examen doit préciser s'il y a une tumeur, s'il y a une inflammation ou une infection à ce niveau-là.

Après l'examen sous spiculum, il faut faire un toucher vaginal pour préciser l'état de l'utérus, la taille de l'utérus, sa position, s'il y a une douleur au niveau de la mobilisation de l'utérus, si l'utérus est hypermobile, surtout dans les douleurs chroniques, ça peut évoquer une déchirure des ligaments de l'utérus. Il faut aussi préciser si l'utérus est fixe, et ça peut nous orienter vers soit des adhérences, soit de l'endométriose, soit un cancer localement avancé. Le toucher vaginal va préciser aussi l'état des annexes, par la présence ou non d'une masse, d'un empattement, ou d'une douleur élective au moment du toucher vaginal associé au palpect abdominal.

Le toucher vaginal va préciser aussi l'état du cul de sac de glace, par la présence d'une éventuelle masse, d'un empattement, d'une douleur élective, voire d'un nodule qui peut évoquer un nodule de type endométriose. Le toucher rectal nous donne des renseignements proches du toucher vaginal. On le fait essentiellement au cas de suspicion d'endométriose, de cancer utérin ou de tumeur, pour voir le rapport par rapport au rectum, mais surtout le rapport latéral vers le rectum.

Il y a un intérêt aussi chez la jeune fille, quand on ne peut pas faire le toucher vaginal, on peut le remplacer par le toucher rectal. Après cet interrogatoire et l'examen, on sera orienté vers un diagnostic et on doit demander des examens complémentaires. Le premier examen qu'on doit demander, surtout chez la femme en période d'activité génitale et qui a des douleurs péloriennes aiguës, c'est d'éliminer une grossesse par le dosage des bêtas ACG.

Il faut faire un bilan infectieux, numérisation fermée sanguine, CRP de prélèvement bactériologique, mais surtout l'échographie abdominaux pélorienne qui est un complément indispensable à l'examen clinique. Cette échographie pélorienne va nous dire s'il s'agit d'une grossesse intra ou extra utérine. Cette échographie va préciser l'éventuelle présence d'une masse et va caractériser cette masse selon son origine, la nature, son aspect échographique, la taille, mais aussi les rapports de cette masse avec les organes de voisinage.

Et cette échographie va préciser aussi s'il y a un épanchement ou non. Dans un contexte d'urgence, et quand on a un doute diagnostique alors qu'on suspecte une urgence, la celluloscopie peut trouver son intérêt, par exemple quand il y a un diagnostic différentiel, douleur de la fosse iliaque droite, et on a le doute entre une appendicite ou une salpingite, on peut être amené à faire une celluloscopie en urgence diagnostique et opératoire. Quand on suspecte ou quand on a une masse, une tumeur, à l'examen clinique et à l'échographie, on peut être amené à demander un scanner pélvien ou un IRM pélvien.

Concernant l'hystérosalpingographie, c'est un examen qui est réservé chez les femmes qui ont un problème de fertilité, et quand on suspecte, surtout à l'échographie, une pathologie intracavitaire d'origine endométriale, on peut demander une hystéroscopie. D'autres examens peuvent être demandés en fonction du contexte clinique et paraclinique. On peut être amené à faire une ponction d'acide avec l'analyse d'acide.

En urgence, on peut, quand on suspecte une grossesse extra-utérine rompue, on peut ponctionner le cuir de sac de glace, c'est le cuir de synthèse, et s'il est positif, s'il ramène du sang, il ne faut pas attendre et il faut opérer cette patiente en urgence. Dans un contexte tumoral, quand on suspecte une tumeur, par exemple de l'ovaire, on peut être amené à demander un certain nombre de marqueurs tumeurs. Maintenant qu'il y a le diagnostic étiologique, donc il faut toujours scinder trois rubriques, les algépélviennes aiguës, qui révèlent souvent des urgences, qu'elles soient gynécologiques ou extra-gynécologiques, et puis les algépélviennes chroniques, qui peuvent être cycliques ou non cycliques.

Concernant les algépélviennes aiguës, elles peuvent être gynécologiques ou non gynécologiques. Les causes gynécologiques sont dominées par le risque de grossesse extra-hétéris, qui représente une urgence vitale, les salpingites aiguës, les complications des kystes ovariens type torsion d'annexe, une hémorragie intra-kystique, voire une rupture du kyste, et puis les complications aiguës du fibrome utérin type torsion, surtout dans les fibromes sous-séreux, ou une nécrobiose qui peut être septique et aseptique. Mais aussi il y a les causes non gynécologiques qu'il faut connaître, surtout quand on a la douleur qui siège au niveau de la fosse iliaque droite, le diagnostic peut être difficile, le diagnostic différentiel avec un éventuel appendicite.

Quand la douleur siège au niveau de la fosse iliaque gauche, le diagnostic différentiel se pose avec une cécocolite, et puis il y a toutes les pyélonéphrites qui peuvent simuler des pathologies gynécologiques, puis il y a les coliques néphrétiques, les occlusions digestives aiguës et les coliques spasmodiques qui peuvent poser un diagnostic différentiel dans ce contexte-là. Donc on a des allergies péviques, donc il faut voir les antécédents, s'il y a des troubles de règles, des signes d'accompagnement, et puis faire un examen clinique et quelques examens paracliniques simples, bêta-ACG, bilan infectieux et l'échographie pévienne. Et quels sont les dangers probables? C'est surtout, il faut chercher une grossesse extra-hétéris, surtout si elle est rompue,

qui va représenter une urgence vitale, c'est des hémorragies intracrystiques, les serpingites, les torsions d'annexe, qui représentent aussi une urgence fonctionnelle au niveau du lot vert, et puis les autres dangers, les appendicites, les céphalées, et des fois on peut trouver des troubles de l'ovulation.

S'il n'y a aucun élément front d'orientation vers un diagnostic grave, il faut surveiller la patiente, donner des antalgiques, et voir soit l'évolution est favorable et la patiente peut partir chez elle, mais en cas de résistance à la douleur, on peut être amené à faire une celioscopie, diagnostic d'abord, et si on trouve une utilisation, il faut la traiter en même temps. Concernant les algipèdes chroniques, cycliques, les dysménorrhées, c'est des douleurs des règles, elles peuvent être primaires ou essentielles. Secondaire, c'est surtout qu'il faut éliminer les endométrioses, c'est l'étiologie la plus fréquente des dysménorrhées secondaires, et puis il y a les dystrophies ovariennes.

Alors quand la douleur survient juste avant les règles, c'est le syndrome prémenstruel, et souvent il est secondaire à une insuffisance lutéale, et quand la douleur survient à la moitié du cycle, là c'est souvent des ovulations douloureuses dans le cadre du syndrome intermenstruel. Alors concernant les algipèdes chroniques, non cycliques, sans rapport avec le cycle menstruel, sans rapport avec les règles, les étiologies peuvent être d'origine gynécologique, mais aussi extra-gynécologique, mais aussi dans un bon pourcentage, ces étiologies sont d'origine psychosomatique, mais bien évidemment il s'agit là d'un diagnostic d'exclusion, un préservoir éliminé, une origine organique. Concernant les étiologies gynécologiques, on trouve en premier plan l'endométriose, l'endométriose externe, et l'endométriose interne appelée aussi adénomyose, quand l'endométriose siège au niveau du muscle utérin.

Puis on peut trouver toutes les séquelles des infections génitales hautes, c'est la maladie inflammatoire pelvienne qui va laisser des séquelles douloureuses, surtout après plusieurs épisodes d'infection. Les dystrophies ovariennes aussi peuvent être responsables d'algues pelviennes chroniques non cycliques, les malpositions utérines, les rétroversions utérines, le syndrome de Master Allen, c'est une douleur post-accouchement par rupture ligamentaire. Et puis toutes les troubles de la statique pelvienne, dont la descente d'organes, le prolapsus, peuvent donner aussi des algues pelviennes chroniques non cycliques.

Et puis on va trouver toutes les étiologies extra-gynécologiques du fait de l'anatomie, donc toutes les étiologies urinaires, digestives, mais aussi rhumatologiques. Si on élimine toutes les étiologies organiques, on peut être orienté vers une origine psychosomatique. En conclusion, l'interrogatoire a un rôle essentiel dans le diagnostic étiologique des douleurs pelviennes.

Les deux principaux critères initiaux d'orientation sont l'intensité de la douleur, aiguille chronique, et la périodicité de la douleur par rapport aux règles. Les principales étiologies de douleurs aiguilles sont la grossesse extra-utérine, la torsion d'annexe, et la rupture hémorragique du kyste, d'un kyste ovarien. Les principales étiologies de douleurs chroniques sont les serpingites

chroniques, l'endométriose et le dysfonctionnement ovarien, mais surtout aussi les algues d'origine psychosomatique, après avoir éliminé les étiologies organiques.

Pour les dysménorrhées essentielles, c'est un motif très fréquent de consultation et qu'il faudra gérer, parce qu'ils sont souvent responsables de l'absentisme scolaire, universitaire et professionnel. Je veux remercier.